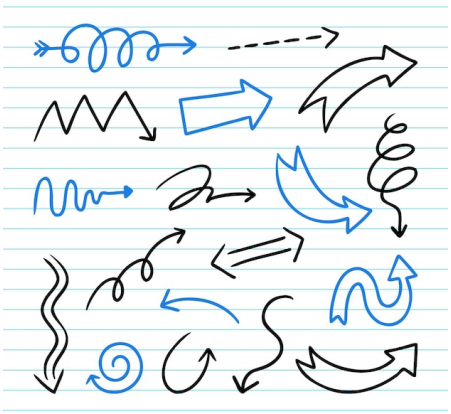


TEMA 36



ESQUEMA DEL TEMA

LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

1.- MARCO LEGAL BÁSICO SOBRE EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.	
Documentos internacionales.	**Declaración Universal de Derechos Humanos, 1.948.** **. Art. 25.** Reconoce el derecho a los servicios sociales (junto a otros sectores como la infancia, la familia, la vejez ...). **Carta Social Europea, 1.961.** **. Art. 14.** Es obligación del Estado la creación y fomento de los Servicios Sociales.
Constitución Española de 1.978.	**. Art. 1.1.** Estado social. **. Art. 9.2.** Promoción de las condiciones para que la libertad de individuos y grupos sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que dificultan su plenitud, participando de la vida política, económica, cultural y social. **. Art. 10.2.** Las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán conforme a la Declaración Universal de DDHH y otros tratados internacionales. **. Art. 14.** Igualdad de los españoles ante la ley. **. Art. 40.1.** Promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico / distribución de la renta regional y personal. **. Art. 50.** Servicios Sociales para la tercera edad. **. Art. 148.1.20.** La asistencia social es competencia exclusiva de las CC.AA.
Estatuto de Autonomía de la CM (L.O. 3/1.983).	**. Art. 26.1.23.** Promoción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención. **. Art. 26.1.24.** Protección y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud. **. Art. 26.1.25.** Promoción de la igualdad respecto a la mujer.
Leyes de Servicios Sociales de primera generación.	(La primera fue en el País Vasco en el año 1.982). **. Ley 11/1.984, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.**
Ley 7/1.985, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.	(Cambios producidos por la Ley 27/2.013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local). **. Art. 25.2.e.** Es competencia de los municipios (de más de 20.000 habitantes) la evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. **. Art. 27.3.c.** La Administración del Estado y las CC.AA. podrán delegar en los municipios diversas competencias: prestación de servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia contra la mujer.

Plan Concertado de Prestaciones Básicas (1.988).	Desarrollo en los municipios de cinco prestaciones básicas: Información y Orientación, Apoyo a la unidad de convivencia y ayuda a domicilio, Alojamiento alternativo, Prevención e inserción social y Fomento de la solidaridad y cooperación social. El Plan Concertado financia a nivel local Centros de Servicios Sociales, Centros de Acogida y Albergues.
Ley 11/2.002, de ordenación de la actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de mejora de la calidad.	Los Servicios Sociales son el conjunto de actividades, prestaciones y equipamientos que tienen por objeto promover y posibilitar el desarrollo del bienestar social de todos los ciudadanos, mediante la prevención, tratamiento o eliminación, en su caso, de las causas que impiden o dificultan el pleno desarrollo de los individuos o de los grupos en que se integran.
Leyes de Servicios Sociales de segunda generación.	(La primera fue en Galicia en el año 1.993). **. Ley 11/2.003 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.**
Leyes de Servicios Sociales de tercera generación.	La primera fue la de Navarra en el año 2.006. **. Ley 12/2.022, de 21 de noviembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.**
Catálogo de Referencia de Servicios Sociales, 2.013.	El sistema público de servicios sociales es un conjunto de servicios y prestaciones que, insertándose con otros elementos de protección social, tiene como finalidad la promoción y el desarrollo pleno de todas las personas y grupos dentro de la sociedad para obtener un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida en el entorno de la convivencia, y la prevención y la eliminación de las causas que conducen a la exclusión social.
Documentos importantes para Madrid.	**. Ley 22/2.006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.** El Ayuntamiento de Madrid puede promover toda clase de actividades y prestar todos los servicios públicos que afecten al interés general de los ciudadanos y no estén expresamente atribuidos a otras administraciones públicas. **. Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, 2.017.** Propone 22 metas o derechos. **. Acuerdos de la Villa de la ciudad de Madrid, 2.020.** **. Acuerdos por un Nuevo Sistema Público de SS.SS. de la Ciudad de Madrid.** 31 de mayo de 2.022. **. Plan Estratégico de SS.SS., 2.023-2.027. Nuevo Sistema Público de SS.SS. de la Ciudad de Madrid.**

2.- LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y LA ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA SEGÚN LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES.

LEY 12/2.022, DE 21 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Título I, Capítulo III, Organización funcional.

El SPSS se organiza en el nivel de ASP y ASE → Criterios de complementariedad y coordinación → Continuidad de la intervención a través de itinerarios específicos para cada persona, familia, grupo y comunidad.

LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.

La Atención Social Primaria es la vía normalizada de **acceso de los ciudadanos al sistema de servicios sociales y a las prestaciones del mismo.** Tiene **carácter polivalente** → atención social individualizada, específica, cercana y en el propio entorno de la persona.

El equipamiento básico en el nivel de Atención Social Primaria será **el centro municipal de servicios sociales (Entidades Locales)**. El conjunto de centros municipales de servicios sociales, con sus equipos profesionales correspondientes, formará la **Red de Atención Social Primaria de la Comunidad de Madrid**.

Los Centros de SS.SS. se distribuirán por criterios de población, necesidad y oportunidad.

Los Centros de SS.SS. serán de titularidad pública.

Funciones de la ASP.	1. **Recepción, detección y análisis de necesidades y demandas sociales** en su ámbito de intervención. 2. **Diagnóstico y valoración técnica de situaciones, necesidades o problemas individuales o colectivos**, sin perjuicio de lo previsto en el ámbito de la atención y apoyo a la discapacidad y a las personas en situación de dependencia. 3. **Identificación de situaciones y ámbitos sociales de riesgo** para el desarrollo de acciones de carácter preventivo y respuesta temprana. 4. **Atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social** y establecimiento de las acciones más adecuadas de acuerdo con el **diagnóstico social**. 5. **Atención profesional personalizada en los ámbitos personal, familiar y comunitario**, que incluyen la **información, valoración y el acompañamiento**, así como, si se considera pertinente, el **seguimiento y coordinación de otras medidas o prestaciones de Atención Especializada**. 6. Actuación en situaciones de **urgencia y emergencia social**. 7. **Gestión y seguimiento de prestaciones económicas y servicios de acompañamiento** vinculados a ellas. 8. Fomento de la **participación, la solidaridad y la cooperación social**. 9. **Emisión de informes sociales, de derivación** o que les sean requeridos por vía administrativa o judicial, en relación con la intervención social realizada. 10. Impulso de **proyectos de intervención en los ámbitos grupal y comunitario**. 11. **Coordinación con el nivel de Atención Social Especializada**, así como con otros sistemas y servicios dirigidos a la promoción del bienestar y la calidad de vida.

Profesional de referencia → TS de ASP → Referencia para los usuarios / coherencia a las intervenciones / Acceso a los servicios y prestaciones / Seguimiento del plan personalizado, de la atención social y de la Historia Social Única.

LA ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA.	
La Atención Social Especializada es la estructura destinada a **atender necesidades singulares de personas o grupos** → Programación, implantación y desarrollo de acciones mediante recursos materiales, técnicos y profesionales.	
Se desarrollan actuaciones y se crean **equipamientos adecuados para la atención específica de personas o grupos** (se recogerán en la Cartera de Servicios del SPSS).	
El acceso a la ASE se realizará a propuesta de los SS.SS. de ASP (salvo excepciones).	
El conjunto de **prestaciones, servicios y equipamientos, residenciales o no residenciales**, destinados a un mismo sector de atención, constituirá una **Red Especializada de Servicios Sociales**.	
Funciones de la ASE.	a) **Valorar, diagnosticar y orientar a personas, familias o grupos** en situaciones que, por su especificidad, requieren una atención que excede el ámbito de prescripción de los servicios de Atención Social Primaria. b) Proporcionar **prestaciones de servicios o económicas**, de forma conjunta o alternativa, a personas que presenten **dificultades físicas, psíquicas o sociales**, con el objetivo preferente de su inclusión social o la prevención de su dependencia y promoción de su autonomía personal en el marco de la legislación vigente, mediante una **actuación preferente en su entorno** o, cuando esto no sea posible, mediante el recurso a **centros residenciales** en los casos necesarios. c) Gestionar y equipar los **centros y servicios que proporcionan prestaciones especializadas a personas y grupos.** d) Promover **medidas de reinserción e inclusión social** orientadas a normalizar las condiciones de vida de las personas que reciben prestaciones o servicios especializados.

3.- CONEXIÓN OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2.030) Y ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo.

. Red municipal de Centros de SS.SS., Ordenanza municipal de ayudas económicas, colaboración con CM en instrucción y seguimiento RMI.

ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

. Participación en la Mesa de Seguimiento del Pacto de Milán, Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible de la Ciudad de Madrid, red de escuelas infantiles, Tarjeta Familias (ayudas económicas para cobertura necesidades básicas de alimentación), Clausulas de comercio justo, proximidad, sostenibilidad (en los centros de acogida, comida a domicilio, Centros de Día para personas mayores).

ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades.

. Información y educación sexual en programas juveniles QuedaT.com, espacios de ocio autogestionados "Enredaderos", Espacios de Igualdad Municipales, Estrategia Municipal sobre la prevención y atención a la adicción al juego.

ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas.

. Red de escuelas infantiles, programa de prevención y control del absentismo escolar, programa ASPA, Quedamos al salir de clase, Centros de Día Infantiles.

ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.

. Estrategia de Transversalidad, Red de Espacios de Igualdad, Red de atención a víctimas de VG, red de atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual en contextos de prostitución. Madrid Segura para Mujeres y Niñas.

ODS 8. Trabajo decente y desarrollo económico.

. Programa ASPA, Programa de "Campaña de verano y otoño joven", Espacios de Igualdad.

ODS 10. Reducir la desigualdad entre los países y entre ellos.

. Atención a personas migrantes en tránsito (alojamiento de emergencia y cobertura necesidades básicas). Acciones de intervención y acompañamiento social a personas migrantes vulnerables. Oficinas Municipales de Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de la población inmigrante.

ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

. Red de atención PSH. Intervención en la Cañada Real.

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Sistema Integrado de Información (transparencia en la gestión). Implementación del IV Plan Local de Infancia y Adolescencia, 2.020-2.023. Comisiones de Participación de la Infancia y la Adolescencia.

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.

. Estrategia de Localización Municipal de los ODS, colaboración entre las AG y los distritos, colaboración con órganos de participación (Foros, Consejos Sectoriales), colaboración con Universidades, Tercer Sector, y con el sector privado (Foro Madrid Empresas y Red de Empresas corresponsables).

4.- LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

La estructura de la ASP del Ayuntamiento de Madrid se ha ido configurando a partir de una serie de documentos.

1.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE SS.SS. Junio, 1.989.

. Objeto del Reglamento: regular las competencias, organización y funcionamiento de todos los Centros SS.SS., como equipamiento básico de la red de SS.SS. / Desarrollo de las prestaciones del Sistema Público de SS.SS. gestionadas desde los Centros de SS.SS.

- Los Centros dividen su territorio en zonas. El acceso es directo. Desde los Centros SS.SS. se deriva a los SS.SS. Especializados.
- Atención directa, estudio y valoración de estados de necesidad, gestión de prestaciones y puesta en marcha de actividades.

. Prestaciones básicas del Sistema de SS.SS.: Información y orientación / Apoyo a la unidad convivencial y ayuda a domicilio / Prevención e inserción social / Alojamiento alternativo.

El acceso a las prestaciones implica la valoración de situaciones de necesidad por los TS.

Establece un conjunto de **derechos** (recibir información, presentar reclamaciones) y **deberes** (colaborar con el Centro, informar verazmente, realizar las actuaciones establecidas).

. Funcionamiento de los Centros SS.SS.

Unidad administrativa.	Recepción y canalización de la demanda de los usuarios (diferenciando los que serán atendidos en el Centro de SS.SS.).
Unidad Trabajo Social.	Atención directa al usuario / contacto con la población y entidades del territorio del Centro → información, orientación, asesoramiento, conocimiento de las necesidades sociales, sistematización de la información para la planificación.
Unidad Programas.	Apoyo técnico a la UTS / gestión de las prestaciones de cada Programa: - Programa de Prevención y Reinserción. - Programa de Convivencia Familiar.

2.- CIRCUITO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES (En 1.996 se inicia un proceso de mejora en los Centros -nuevas necesidades y crecimiento de los recursos-; en 1.997 se presenta el **modelo de atención). En 1.998** se pone en marcha en los 21 Distritos.

. Diagnóstico previo: disparidad de modelos organizativos / indefinición de objetivos y criterios de atención / listas de espera.

. Objetivos del modelo: homogeneizar los modelos de atención en los 21 distritos / racionalizar los recursos humanos y las prestaciones / agilizar la atención.

. Modelo de atención:

Unidad Administrativa .	El acceso al centro se realiza a través de la Unidad Administrativa: - Recepción y canalización de usuarios. - Diferenciación usuarios susceptibles de atención en el Centro. - Información de horarios y requisitos para ser atendidos en UTS de PA o citados en UTS de Zona.

Unidad de Trabajo Social.	Atención directa a la ciudadanía. La UTS se desdobla: - UTS de Primera Atención (UTS PA): intervención breve en el tiempo / casos que no requieren seguimiento → acogida/contextualización, información y asesoramiento, orientación, gestión y valoración de determinadas prestaciones, análisis de la demanda distrital, atención grupal, coordinación y cierre/derivación. - UTS de Zona: intervención prolongada que requiere seguimiento (Diseño de Intervención Social) → atención con seguimiento (Historia Social y DIS), atención grupal, trabajo comunitario, gestión de prestaciones (que requieren seguimiento).
Unidad de Programas.	. Programa de Prevención y Familia / Programa de Mayores y Ayuda a Domicilio: - Coordinación interna (con el equipo y los recursos municipales). - Coordinación externa (con las entidades contratadas y concertadas). - Apoyo a las UTS en el desarrollo de proyectos sociales específicos.

. Circuito de atención al ciudadano.

Itinerario por el cual el ciudadano es atendido en los Centros de SS.SS.

Acceso al circuito.	. El acceso se realiza a través de la Unidad Administrativa, recepcionando y discriminando entre:
	Usuarios en PA: 1.- Usuarios nuevos (no tienen expediente en ASP o no han tenido atención en los últimos 12 meses). 2.- Usuarios en situación de urgencia → 5 supuestos: agresiones o malos tratos manifiestos o no / abandono de personas sin apoyo ni recursos / problemas de alojamiento y vivienda sobrevenidos / desprotección social relacionada con problemas de salud / desprotección socio-familiar derivada de emergencias.
	Usuarios en Zona.: 1.- Usuarios con expediente activo en ASP. 2.- Usuarios derivados de PA.
Primera Atención.	. Atención a usuarios nuevos y casos urgentes (por propia iniciativa o derivados de otros servicios). . Cierre en PA: finalización-resolución en PA / derivación a UTS de Zona / derivación externa a otros servicios o sistemas de protección / abandono / fallecimiento.
Atención en Zona.	. Usuarios derivados de PA y usuarios con expediente activo. Se atiende con cita previa de la Unidad Administrativa. . Itinerarios en la UTS de Zona: intervención exclusiva y específica en Zona / intervención en Zona con derivación parcial / Intervención en zona con derivación definitiva.

. Funciones de los profesionales de las UTS.

Funciones en PA.	Acogida-contextualización / Información-orientación / asesoramiento / cumplimentación ficha usuario primera atención (FUPA) / gestión / valoración / cierre-derivación.
Funciones en Zona.	Apertura de Historia Social / Intervención con Diseño de Intervención Social (DIS) / seguimiento y evaluación de la intervención / cierre-derivación.

. Metodología para la intervención social.

Criterios de intervención en PA.	. Puerta de entrada a los SS.SS. → Valoración inicial y detección del riesgo social. . Características metodológicas: breve en el tiempo / sin seguimiento / valoración rápida / intervención (si procede) en situaciones de crisis / resuelve / finaliza y deriva. . Máximo de 3 entrevistas → Gestión puntual de prestaciones o gestión de prestaciones que no requieren seguimiento (p. ej, prestaciones de la CM).
Criterios de intervención en Zona.	. Intervención sistematizada que requiere seguimiento → Parte del conocimiento de la realidad / formula hipótesis de trabajo. . Objetivos de la intervención en Zona: prevención / modificación / contención. . Los soportes que utiliza son la Historia Social y el DIS. . Se diferencia: - Intensidad: alta (7-14 entrevistas anuales) / media (3-6 entrevistas anuales) / baja (1-2 entrevistas anuales). - Frecuencia (número de intervenciones en un período de tiempo determinado). . La duración del proceso de intervención no debe exceder de los 2 años. . Los niveles de intervención son: - Individual/familiar: recepción de casos / entrevistas / visitas / coordinación con otros profesionales y servicios / gestión de recursos. - Grupal: Análisis de la demanda y atención de la zona / propuestas sobre intervenciones grupales / prediseño del grupo / elaboración de diseño de intervención grupal. - Comunitario: valoración de casos para abordaje comunitario / participación en reuniones y asociaciones / coordinación con redes naturales y sociales.
Atención a las urgencias sociales.	La atención a las urgencias se garantiza durante el horario de apertura del Centro (fuera de ese horario es competencia del Samur Social). . La atención a urgencias debe cumplir dos criterios: vinculación territorial / horario de apertura de los Centros.

Atención desde la Unidad de Programas.	Se plantean dos programas: Programa de Prevención y Familia y Programa de Mayores y Servicio de Ayuda a Domicilio. - Se adscribe un TS a cada Programa → racionalizar el uso de tiempos y tareas / diferenciar las tareas de apoyo directo y las de coordinación/apoyo técnico / coordinación de prestaciones y proyectos. - Funciones de coordinación: coordinación interna (con la UTS de Zona, con el equipo del Centro, con otros recursos municipales) y coordinación externa (con entidades concertadas y contratadas, con Comisiones, Mesas de Trabajo …). - Puede asumir funciones de diseño y desarrollo de proyectos distritales específicos.
Atención a menores.	Recepción de informaciones telefónicas relacionadas con menores y coordinación con la UTS de Zona correspondiente (para responder a peticiones de Zona, Fiscalía, ARRMI …).

3.- PLAN DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA, 2.008-2.011.

Organizar la ASP del Ayuntamiento desde la orientación al usuario.

. Los SS.SS. son un sistema mixto con una estructura de gestión compleja.

Visión de la ASP (futuro).	. Que sean conocidos y reconocidos como el núcleo de los derechos sociales. . Se concibe como una red eficaz e interconectada de centros y servicios, con equipos capaces de garantizar la calidad de la atención y la gestión integrada de programas y prestaciones. . Con el reto de cercanía y adaptación e innovación en la respuesta a las necesidades sociales del distrito.
Misión de la ASP.	Prestar servicios de atención social para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos / promoviendo la innovación / ofreciendo respuestas ágiles y eficaces para la resolución de sus demandas y satisfacción de sus necesidades.
Objetivo general de la ASP.	Afianzar la **presencia, reconocimiento e identificación de la Atención Social Primaria entre la ciudadanía madrileña, como canalizadora del sistema de prestaciones de responsabilidad pública** que expresa la solidaridad y el compromiso de la sociedad hacia el conjunto de sus miembros.
Objetivos específicos de la ASP.	1.- Avanzar hacia la **reorganización de los Servicios Sociales, ofreciendo servicios con la máxima calidad y eficacia a la población.** 2.- **Ampliar, consolidar y adaptar los recursos y equipamientos de cada distrito a sus características**, ajustando su organización a criterios sociodemográficos y territoriales. 3.- Dirigir al conjunto de la organización a establecer **criterios compartidos y compromisos para su concreción en el Área y en los distritos.**

4.- PLAN DE MEJORA DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA, noviembre de 2.017.

1.- Diagnóstico de situación del modelo organizativo de los Centros De SS.SS. del Ayuntamiento.

Hay que tener en cuenta el impacto cualitativo en la ASP de la implantación de la Ley de Dependencia, la Ordenanza de Prestaciones para mayores, la Ordenanza de ayudas económicas y la ampliación del número de Centros de SS.SS. Desde el año 2.008 además dentro de una severa recesión económica. A pesar de que se ha incrementado la plantilla las cargas de trabajo generadas se han multiplicado en todas las prestaciones.

2.- Propuestas de mejora.

El Plan de Mejora se alinea en los ejes municipales de "Una ciudad cercana, cohesionada y habitable" y "Una ciudad centrada en las personas, solidaria e inclusiva", dentro de los objetivos estratégicos "Promover la cohesión y el equilibrio territorial" y "Garantizar la equidad social reconociendo la diversidad de la población de Madrid".

Objetivo general. Mejorar el acceso de la ciudadanía a la red de ASP, como canalizadora del sistema de servicios y prestaciones sociales de responsabilidad pública municipal, y motor de solidaridad e inclusión social.

3.- Áreas de Mejora.

1.- Los profesionales de los SS.SS.

Los Departamentos de SS.SS. están compuestas por personal técnico (TS y técnicos de acogida e integración social) y profesionales de apoyo (personal administrativo. Auxiliares de SS.SS., Auxiliares Administrativos, secretarias y Personal de Oficios Internos).

- Aumento del número de profesionales (para alcanzar la ratio de 1 TS / 4.500 habitantes).
- Incorporación de nuevos profesionales en las Unidades Funcionales de los Centros: Acogida e Información (técnico de acogida e integración social, Auxiliar SS.SS. y TS) / Tramitación y gestión (Administrativo, auxiliar administrativo y técnico de gestión) / Intervención social (TS, psicólogo, educador social, terapeuta ocupacional) / Dirección (TS y auxiliar de secretaría).
- Se propone una plantilla básica para cada una de las unidades funcionales.

2.- El turno de tarde.

Es necesario equiparar el funcionamiento de los Centros SS.SS., sea cual sea el horario de atención para garantizar una atención de calidad.

3.- Los canales de comunicación.

La accesibilidad de los servicios públicos en un valor fundamental. Se ha detectado una deficiente cartera de trámites electrónicos, infrautilización del canal telefónico y la necesidad de incorporar el correo electrónico como canal de comunicación en la intervención individual/familiar.

4.- Los procesos de trabajo.

Los procesos de trabajo son complejos (hay más de un centenar de procesos diferentes con criterios que dependen del Distrito y del AG). Además, hay procesos que dependen de la CM. Es necesario un mapa de procesos más claro y simplificado.

5.- Las Agendas de los profesionales.

Son numerosas las dificultades en la gestión de las agendas (diferencias entre mañana y tarde, necesidad de optimizar las citas -dado el elevado número de personas que no acuden a cita-, criterios heterogéneos de gestión de las agendas …

6.- La atención grupal.

Frente a la prioridad de la atención individual se plantea la necesidad de implantar modelos grupales y comunitarios, pero la intervención grupal carece de metodología y organización homogénea, la práctica es desigual y minoritaria, no es aceptada por todos los profesionales …

7.- La formación.

Es un derecho y un deber individual de los empleados públicos. En ocasiones la participación en la formación es escasa, hay grupos sin formación específica (POSIs), la percepción es que la formación es insuficiente … Es necesario actualizar las competencias y la cualificación específica de los colectivos para desarrollar capacidades y aprender nuevos conocimientos para mejorar la calidad de los servicios prestados.

8.- La homogeneidad organizativa.

La realidad social de Madrid es diversa y cambiante y la respuesta del Ayuntamiento está compuesta por elementos de la misma naturaleza integrados en una estructura uniforme. El modelo organizativo ha provocado un acceso desigual de la ciudadanía y ha derivado en la desigualdad en las cargas de trabajo.

9.- Los aplicativos de gestión.

El volumen de intervención de los Centros de SS.SS. requiere un aplicativo de gestión integral con capacidad para integrar todos los agentes que intervienen en la red de atención. Se requiere incorporar nuevas funcionalidades en CIVIS que ayuden en la simplificación de los procesos de trabajo y de la labor de los profesionales, avanzando hacia unos SS.SS. modernos, accesibles, transparentes y eficientes.

5.- INSTRUCCIÓN 1/2.018, SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE SS.SS. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

La función principal de los Centros SS.SS., como equipamiento básico de la ASP, es garantizar la atención social a la ciudadanía en los 21 distritos del municipio.

Criterios generales sobre organización de la atención social.	. Cada TS queda adscrito a la UTS de PA o a la UTS de Zona / Cada TS dispone de una agenda (para registrar las citas semanales, individuales o grupales). . El reparto de la ciudadanía entre mañana y tarde vendrá determinado por los criterios de volumen de carga. **. Atención al público:** es diaria, de lunes a viernes en la franja horario de mañana (entre las 9.00 y las 13.30) y de tarde (entre las 15.00 y las 19.30). **. Actividad profesional:** - Atención con cita previa, tanto en PA como en Zona (individual o grupal). - Atención y gestión profesional: visitas a domicilio (prioritarias), atención a la ciudadanía, coordinación interna, coordinación externa, tramitación y gestión de servicios y prestaciones …
Organización de la UTS de PA.	. Se atiende, mediante cita previa, 4 días a la semana (dos de ellos, martes y jueves). Cada Centro podrá elegir entre lunes, miércoles y viernes (garantizando que se atienda todos los días de la semana). . Atención con cita previa entre las 9.00/13.30 y las 15.00/19.30. . Las citas tienen una duración de 20 minutos. . Se programan 11 citas individuales cada día de atención (disponen de dos citas al día que no se ofertan con cita previa). . Actividad grupal: 2 horas y 10 minutos. . Días con citas individuales y actividades grupales: 1 actividad grupal / 5 citas individuales.

	. En los días que no hay atención presencial → atención y gestión profesional (priorizando las visitas domiciliarias) y elaboración de informes (para la gestión de la dependencia).
Organización de las UTS de Zona.	. Atiende, mediante cita previa, 3 días a la semana: lunes, miércoles y viernes. . Se atiende con cita previa: entre las 9.00/13.30 y las 15.00/19.30. . Las citas tienen una duración de 30 minutos. . Se atiende a 8 citas individuales al día (2 citas se ofertan sin cita previa). . Actividad grupal: 2 horas. . Días con citas individuales y actividades grupales: 1 actividad grupal / 4 citas individuales.
Organización de la actividad grupal.	. 2 grupos informativos con periodicidad semanal (coordinador por TS de PA). . Grupos de intervención social (coordinados por UTS de Zona).
Situaciones excepcionales.	**Urgencias.** . Casos de urgencia sin expediente en Centro SS.SS. → UTS de PA. . Casos de urgencia con expediente de alta → UTS de Zona.

6.- CARTA DE SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

Fecha de aprobación: 15 de julio de 2.010 / Fecha de última evaluación: 23 de marzo de 2.023.

Son la unidad o equipamiento básico donde se prestan los servicios de ASP → Puerta de entrada de la ciudadanía al Sistema Público de SS.SS. y sus prestaciones (del Ayuntamiento, de la CM o de otras Administraciones).

. **40 Centros de SS.SS. que atienden los 21 Distritos (este dato coincide con la información de la página web).**

. Se asigna un TS de referencia para la atención personalizada y para asegurar la coherencia y globalidad de la intervención.

. Se alinea con los ODS:

- **1**, Fin de la pobreza.
- **4**, Educación de calidad.
- **5**, Igualdad de género.
- **16,** Paz, Justicia e instituciones sociales.

. Servicios prestados.

Información y orientación sobre servicios sociales y otros sistemas de protección social.
. Acogida a la persona. . Información individual o grupal sobre derechos y prestaciones / requisitos de acceso. . Realización de la valoración inicial de la demanda individual, familiar o grupal. . Detección de otras situaciones de necesidad. . Orientación sobre opciones y alternativas para responder a la demanda. . Facilitación del acceso a otros servicios.

Asesoramiento social.

. Valoración de la demanda planteada aplicando instrumentos de valoración teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares y sociales.

. Propuesta de alternativas de actuación según la valoración realizada y los recursos disponibles.

. Apoyo profesional en la toma de decisiones.

Apoyo social y seguimiento.

. Valoración de las necesidades y problemas identificados, elaborando el diagnóstico social.

. Diseño, de acuerdo con la persona o familia, del programa de intervención.

. Puesta en marcha del programa de intervención para responder a las necesidades y problemas identificados, por medio del acompañamiento social y la asignación de servicios y recursos disponibles.

. Coordinación con otros profesionales y servicios.

. Atención continuada -individual, familiar y grupal- evaluando periódicamente el programa de intervención.

Atención de situaciones de desprotección social.

. Valoración inicial del grado de riesgo y urgencia de la situación.

Se consideran supuestos de urgencia:

- Agresiones o malos tratos, manifiestos o no, a cualquier persona.
- Abandonos por acontecimientos sobrevenidos → pérdida de apoyo en personas sin recursos personales y/o familiares → grave vulnerabilidad.
- Pérdida inminente de alojamiento/vivienda: desahucios, pérdida de vivienda o demoliciones no previstas o desconocidas previamente por SS.SS.
- Situaciones de desprotección social relacionadas con problemas de salud de personas con falta de autonomía personal, sin apoyo familiar suficiente y escasez de recursos económicos.
- Situaciones de desprotección sociofamiliar derivadas de emergencias (atendidas previamente por los servicios de emergencia).

Gestión de servicios y ayudas sociales.

. Valoración técnica de la situación de la persona y planteamiento de los servicios y ayudas sociales disponibles.

. Tramitación de servicios y ayudas sociales del Ayuntamiento, la CM, de otras administraciones y entidades de iniciativa social, de acuerdo al programa de intervención.

. Propuesta de concesión de los servicios o ayudas municipales correspondientes, teniendo en cuenta los recursos disponibles.

. Seguimiento de los servicios y ayudas para asegurar su correcta aplicación y adecuación a la necesidad valorada.

. Apoyo técnico a proyectos de iniciativa social y/o entidades con los que se han establecido convenios.

Trabajo Social Comunitario.
. Identificar y dar a conocer las actividades que las Asociaciones y Entidades desarrollan en los distritos. . Orientación a entidades y asociaciones sobre las iniciativas comunitarias del distrito. . Impulso del encuentro, coordinación y cooperación entre entidades y asociaciones. . Detección y canalización de las demandas de participaciones en acciones de voluntariado social. . Apoyo a la creación de nuevas experiencias solidarias en relación con las necesidades sociales (grupos de ayuda mutua, grupos socioeducativos, grupos socio-terapéuticos). . Difusión de experiencias de trabajo social comunitario. . Propuesta de elaboración de estudios sobre la realidad social de los distritos.
El horario de atención mediante cita previa, es de 9 a 13 y de 15 a 19, de lunes a viernes **Nota: este dato no coincide con el de la Instrucción 1/2.018.**

. Compromisos de calidad.

1.- Facilitar el acceso a los CSSSS, ofreciendo un horario de atención, mediante cita previa, de 9 a 13 y de 15 a 19, de lunes a viernes.

2.- Facilitar una cita a través del sistema de cita previa al 100% de las solicitudes, garantizando una atención personalizada a la ciudadanía. El objetivo es que al menos acudan a la cita el 85% de las personas citadas.

3.- Facilitar que la primera entrevista tenga lugar en el plazo de 8 días hábiles a partir de la fecha de petición de la cita en el 80% de los casos. En el resto se realizará en el plazo de 10 días hábiles.

4.- Garantizar la atención en el día de las situaciones tipificadas como urgentes.

5.- Ofrecer una atención profesional y con un trato amable. La valoración del trato y la atención recibida será igual o superior a 8 en una escala de 0 a 10.

6.- Realizar una atención técnica personalizada, asegurando la intimidad y confidencialidad. La valoración de la atención personalizada será igual o superior a 8 en una escala de 0 a 10.

7.- Dar un servicio de calidad. El objetivo es que la valoración de los SS.SS. Municipales sea, como mínimo de un 6,5 en una escala de 0 a 10.

8.- Disponer de un Centro de SS.SS. por cada 100.000 habitantes y una TS por cada 6.000 habitantes.

9.- Realizar la valoración técnica de las solicitudes de servicios y ayudas municipales en un plazo máximo de 21 días hábiles en el 80% de los casos. En el resto en no más de 45 días hábiles a partir de la entrega de toda la documentación requerida.

10.- Contestar el 60% de sugerencias, reclamaciones y felicitaciones como máximo en 30 días naturales y en ningún caso en un plazo superior a 2 meses.

6.- MEMORIA DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, 2.022.

El Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad en la sesión 7/2022 ordinaria del Pleno de 31 de mayo 2022 los **Acuerdos por un el Nuevo Modelo de Servicios Sociales** que pretende actualizar los Servicios Sociales Municipales a las circunstancias que vive nuestra Ciudad en el Siglo XXI. Las líneas principales que propone el Modelo son:

• Unos **Servicios Sociales centrados en la persona**, sus necesidades, capacidades y derechos. Unos servicios garantistas, orientados hacia las demandas de la ciudadanía y adaptados a sus necesidades.

• Unos **Servicios Sociales integrados**, capaces de ofrecer continuidad de apoyos, tanto a largo plazo como en momentos puntuales. Coordinados con el entorno comunitario y las redes institucionales.

• Unos **Servicios Sociales de calidad**: eficientes, eficaces, ágiles, equitativos y sistemáticos, con metodologías rigurosas para el análisis y planificación de sus servicios.

El **objetivo de los servicios sociales** es el de asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, teniendo cubiertas las necesidades sociales entendiendo como tal las derivadas del derecho de la persona a realizarse como ser social en el ámbito convivencial, interpersonal y familiar, y en el relacional, entre el individuo y su entorno social.

¿QUE SON LOS CENTROS DE SS.SS.?

Los Centros de Servicios Sociales constituyen el equipamiento básico de la Atención Social Primaria. Son el principal acceso al Sistema de Servicios Sociales y a las prestaciones profesionales, económicas y los servicios que dependen de las distintas Administraciones. Además, proporcionan asesoramiento y apoyo social, así como atención a situaciones de desprotección social. Otro de sus ámbitos de intervención se concreta en acciones de mejora en la comunidad en la que se ubican físicamente, favoreciendo la creación de redes de apoyo y participación.

La ciudad de Madrid dispone de una red de Atención Social Primaria compuesta por **40 Centros de Servicios Sociales.**

Todos los distritos de la ciudad cuentan con al menos un Centro de Servicios Sociales. El distrito de Puente de Vallecas cuenta con cuatro, Carabanchel, Latina y Moncloa-Aravaca con tres, otros 10 distritos con dos centros cada uno (Centro, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, San Blas-Canillejas, Tetuán, Usera, Vicálvaro, Villaverde y Villa de Vallecas) y los 7 distritos restantes (Arganzuela, Barajas, Chamartín, Chamberí, Moratalaz, Retiro y Salamanca) con un centro en cada uno.

El Ayuntamiento de Madrid dispone de un Centro de Servicios Sociales por cada 84.273 habitantes.

¿CÓMO FUNCIONAN?

• Horario de atención de los Centros de Servicios Sociales.

• De lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19, con cita previa.

• Acceso a través de cita previa

• Se puede concertar una cita en el centro que corresponda según el domicilio (por teléfono o por correo electrónico) o con el sistema de Cita Previa de Línea Madrid

• Teléfono gratuito 010

ATENCIÓN SOCIAL EN CIFRAS.

En el año 2022 se ha atendido a 431.769 personas con las que se han celebrado 505.413 entrevistas. En relación con el año 2021, en el que se atendieron presencialmente el 19 % de las citas, en este año se ha reforzado la atención presencial, alcanzando un 47 % del total de entrevistas realizadas.

De las 431.769 personas atendidas, 63.284 son nuevos usuarios con alguna atención generada en el expediente, es decir, el 14,65% han acudido por primera vez a los servicios sociales. Se está produciendo un **aumento progresivo de las personas que acuden por primera vez a los servicios sociales**.

Las personas que han acudido por primera vez a los Servicios Sociales de Atención Social Primaria en 2022 son una **población mucho más joven** que el global de las personas atendidas. Al comparar el intervalo de edad de más de 65 años observamos cómo en las personas nuevas representan el 28%, mientras que el total de personas alcanzan el 47%.

En 2022 también se observa una **incorporación progresiva de los hombres como demandantes de atención social.** Este año representan el 41% de las personas que han acudido por primera vez.

Los distritos en los que se ha atendido a mayor número de personas son **Carabanchel, Puente de Vallecas, Latina, Villaverde, Usera y Ciudad Lineal.** Los mismos que encabezaban este ranking el año anterior.

En el año 2022 la atención de los servicios sociales se ha continuado centrando en las **personas mayores de 65 años** (202.876), las cuales representan casi la mitad de las personas atendidas desde los Centros de Servicios Sociales (el 46,98%) principalmente con demandas relativas la dependencia, la teleasistencia, los centros de día y la ayuda a domicilio. Es significativo el **porcentaje de personas mayores de 80 años** atendidas (144.359) que alcanza el (33,43% del total de atenciones prestadas).

En los últimos años se ha modificado el perfil de las personas que acuden a servicios sociales: **crece la presencia de ciudadanos más jóvenes y familias monoparentales.**

Se ha atendido a118.149 personas extranjeras que supone un 27,36% de las personas atendidas por los Servicios Sociales de Atención Social Primaria.

La población con nacionalidad extranjera representa el 15,74% de los residentes en Madrid a 1 de enero de 2022.

Las tres principales prestaciones concedidas nuevas durante en el año 2022 continúan

siendo las mismas que en el año 2021: Dependencia (19%); Servicio de Ayuda a

Domicilio Mayores (15%) y Ayuda Económica Alimentos / Tarjeta Familias (11%). En la

comparativa realizada entre ambos años se comprueba como la Renta Mínima de

Inserción ha pasado del 4º puesto en 2021 al 10ª en 2022, ya que muchos beneficiarios

son ahora perceptores del Ingreso Mínimo Vital.

De las prestaciones concedidas en 2022, cabe destacar: Teleasistencia para personas mayores (40%); el Servicio de Ayuda a Domicilio para personas mayores (32%) y tarjeta familias que suponen el 12% del total de las concesiones.

CONCIERTOS Y CONVENIOS (que se desarrollan en los Centros de SS.SS)

Servicio de Orientación Jurídica.

El Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) tiene como finalidad asesorar en materia jurídica a las personas usuarias de los servicios sociales y a las personas socias de los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento de Madrid. Ofrece información y apoyo en la tramitación de la justicia gratuita.

El SOJ se presta con carácter semanal en los Centros de Servicios Sociales. El acceso se realiza mediante cita previa solicitada por propia iniciativa o por derivación de los profesionales de referencia.

Los letrados también realizan orientación y redacción de escritos en materia de prestaciones que competen a otras administraciones, en las que no sea preceptiva la asistencia letrada.

Oficinas de Información de Prestaciones.

El 1 de noviembre de 2022 abrieron sus puertas las Oficinas de Información de Prestaciones (OIP). Dicho servicio municipal desarrolla tareas de información, orientación y acompañamiento vinculados a la tramitación del Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones y ayudas sociales no municipales a través de cuatro oficinas en el municipio de Madrid, mediante un contrato de servicios.

Es un servicio dirigido a la población en general y se puede acceder al mismo, acudiendo directamente a las oficinas o mediante cita previa. Estas oficinas dan cobertura a los 21 distritos de la ciudad. La atención no está territorializada, siendo de libre elección la asistencia a una u otra.